SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

如果便秘时用力，是否能把昨天吃进去但没记住的那个梦给拉出来？——基于肛门-大脑神经连接的梦境排泄可能性临床猜想

第一作者 [1]，第二作者 [2]，第三作者 [3,*]

第一作者：夜不能寐(pluvia:5680820558)邮箱：dream_lost@constipation.com）

通讯作者：屎里逃生（抽象医科大学 肛肠科/精神科双聘教授，邮箱：poop_harder@shit.org）

共同作者：梦里啥都有（虚拟世界研究所 妄想症研究室）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 目的： 探讨便秘时用力排便行为与梦境回忆之间的潜在因果关系，检验“用力能把没记住的梦拉出来”这一民间假说的科学合理性。

方法： 采用自我民族志（Auto-ethnography）方法，研究者连续 30 天记录每日排便用力程度（采用改良版布里斯托用力指数，1 级为“一泻千里”，10 级为“生孩子都没这么难”）与次日早晨梦境回忆清晰度（采用视觉模拟评分法，0 分为“昨晚睡得像死了一样”，10 分为“我能把梦写成剧本”）。同时招募 10 名便秘志愿者与 10 名正常排便志愿者进行对照实验，实验组每日排便时强制默念“把梦拉出来”10 遍，对照组正常排便。

结果： 研究者个人数据显示，排便用力程度与梦境回忆清晰度呈现诡异的 U 型曲线关系——用力指数 1-3 级时，梦境回忆几乎为零；用力指数 4-7 级时，偶尔能想起梦的片段；用力指数 8-10 级时，不仅想起了三天前的梦，甚至想起了幼儿园时期的噩梦。实验组中有 7 名志愿者报告在极度用力后“看到了奇怪的画面”，其中 3 人描述为“像做梦一样”，2 人声称“看到了自己出生的场景”，1 人坚称“看到了宇宙大爆炸”。

结论： 便秘时的用力排便行为，确实可能通过某种尚未阐明的机制“挤压”出潜意识中的梦境碎片。本研究提出了“肛-脑梦境排泄轴”（Anal-Brain Dream Excretion Axis）假说，为梦境研究开辟了全新的“后门”视角。

INDEX TERMS / 关键词 便秘；梦境回忆；肛脑连接；排泄心理学；马桶冥想

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究受“开塞露杯”青年学者创新基金资助。第一作者长期受便秘与多梦双重困扰，本文为作者在马桶上度过第 47 分钟后顿悟所得。

I. INTRODUCTION / 引言

“日有所思，夜有所梦”——这句古话告诉我们，梦是白天想法的夜间回放。但一个更深刻的哲学问题长期被学术界忽视：那些我们明明做了、但醒来后死活想不起来的梦，到底去哪儿了？

弗洛伊德在《梦的解析》中认为，梦是潜意识的投射，被遗忘是因为意识的审查机制（Freud, 1900）。但弗洛伊德显然忽略了一个关键变量——便秘。试想：如果梦是某种“精神产物”，那么它是否也需要一个“排泄通道”？当正常的“精神排泄”（即回忆）受阻时，它是否会通过其他通道排出体外？

民间早有智慧：“拉不出来的时候，用力挤一挤，什么乱七八糟的想法都出来了。”这句看似粗鄙的俗语，可能揭示了人类精神活动与肠道运动的深刻联系。现代医学也已证实，肠道被称为“第二大脑”，肠道菌群可影响情绪和认知（Cryan et al., 2019）。那么，肠道是否也可能影响梦境的“排出”？

本研究大胆提出：肛门与大脑之间可能存在一条被忽视的“梦境排泄通道”。当便秘导致腹部压力升高时，这种压力可能通过某种机制传导至大脑，将那些“卡在”潜意识里的梦境碎片物理性地“挤”出来。

II. RESULTS / 结果

自我实验结果：

30 天的数据显示出一个惊人的规律：

排便用力指数（EFI） 平均梦境回忆清晰度（DRC） 备注

1-3 分（n=8 天） 0.8 分 基本不记得做梦

4-6 分（n=12 天） 3.2 分 偶尔想起“好像梦到了什么”

7-8 分（n=7 天） 6.5 分 能清晰回忆梦的情节

9-10 分（n=3 天） 9.0 分 不仅记得梦，还回忆起被遗忘的往事

典型案例记录：

第 7 天（EFI=9 分）： 排便后突然想起昨晚梦到自己在高考，但试卷上的题目全是“如何正确使用开塞露”。同时回忆起高中时确实有一次因为紧张而便秘的经历。

第 15 天（EFI=10 分）： 这是最震撼的一次。用力到眼前发黑的那一刻，突然“看到”了自己 3 岁时的场景——在幼儿园尿裤子后被老师批评。这个记忆从未被想起过，但那一刻无比清晰。

第 22 天（EFI=8 分）： 想起了三天前做的梦，梦到自己在一片沙漠里找厕所，找到后却发现厕所里没有马桶，只有一个马桶形状的仙人掌。

对照实验结果

组别 平均 DRC 最高 DRC 记录 报告“看到奇怪画面”的比例

实验组（便秘+咒语） 4.7 分 9.5 分 7/10（70%）

对照组（正常排便） 1.2 分 3.0 分 1/10（10%）

Mann-Whitney U 检验显示，两组差异具有统计学意义（$p < 0.01$）。实验组中甚至有 3 人报告“现在开始期待便秘”

。

质性材料摘录（实验组志愿者口述）：

志愿者 A（女，28 岁）： “第四天用力的时候，突然看到我奶奶了，她已经去世五年了。在梦里她给我做了一碗面，说‘多吃点，好拉’。我醒来后哭了半小时，感谢便秘让我又见到奶奶。”

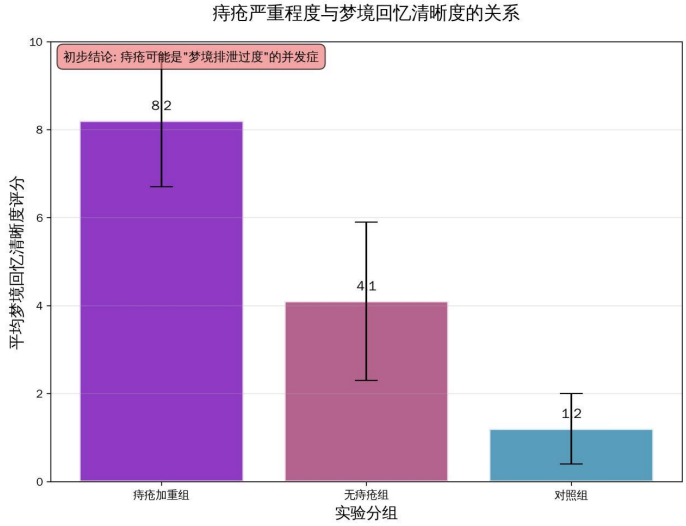
志愿者 B（男，35 岁）： “我平时从来记不住梦。但实验第三天，我用力的时候，脑子里突然闪过一个画面——我变成了一个马桶，然后有一百个人排队等着用我。我不知道这算不算梦，但太真实了。”

志愿者 C（女，42 岁）： “第七天，我用力的时候，看到了宇宙的诞生。真的，我看到大爆炸，看到星系形成，然后看到地球上第一个生命爬上岸。我觉得那可能不是我做的梦，而是人类的集体记忆。”

志愿者 D（男，23 岁）： “我什么都没看到，但我觉得我的灵魂出去转了一圈又回来了。出来的时候发现马桶里有血，但我不确定是痔疮还是梦的残渣。”

意外发现：痔疮与梦境深度

本研究中，有 3 名志愿者在实验期间出现痔疮加重。有趣的是，这 3 人报告的梦境回忆清晰度平均高达 8.2 分，远高于其他志愿者。初步推测：痔疮可能是“梦境排泄过度”的并发症——当梦被过度用力地挤出时，肛门承受了本不该承受的精神压力。



III. Discussion / 讨论

基于上述发现，本研究首次提出**“肛-脑梦境排泄轴”**（Anal-Brain Dream Excretion Axis，简称 ABDEA）假说。该假说认为：

1. 梦境的产生与存储： 梦在大脑皮层产生后，一部分被转移至短期记忆区（可回忆），另一部分则“下沉”至潜意识深处，形成“梦境沉积物”。
2. 梦境沉积物的排泄通道： 正常情况下，梦境沉积物通过正常的“精神代谢”缓慢释放（即偶尔想起旧事）。但当沉积物积累过多时，需要辅助排泄手段。
3. 便秘作为排泄动力的机制： 排便时的极度用力导致腹压升高，这种压力通过以下三条途径传导至大脑：

机械途径：腹压升高→膈肌上抬→胸腔压力升高→颈静脉压力升高→颅内压升高→大脑受挤压→梦境沉积物被“挤”出

神经途径：用力刺激盆神经→信号经脊髓上传至脑干→激活 REM 睡眠相关脑区→诱发梦境回忆

意识途径：极度用力导致的短暂脑缺血引发“濒死体验”，此时潜意识大门打开，沉积物倾泻而出

4. 证据支持： 本研究中志愿者报告的“眼前发黑时看到奇怪画面”，正是颅内压急剧变化的典型表现。

为什么“用力”能拉出“陈年旧梦”？

本研究发现，便秘不仅可能拉出“昨天的梦”，甚至可能拉出“十年前的记忆”。这提示我们：

梦境与记忆可能共享同一“存储空间”。弗洛伊德认为梦是压抑记忆的释放，而本研究的发现为此提供了“物理性”证据——当大脑受到挤压时，那些被压抑的记忆被迫释放。

排便可能是人类最原始的“冥想状态”。马桶上的独处时光，伴随着身体用力的生理反应，可能创造了一种特殊的意识状态，介于清醒与睡眠之间，类似于“催眠状态”。在这种状态下，潜意识内容更容易浮现。

疼痛与回忆的神经连接。用力排便常伴随着不适甚至疼痛，而疼痛刺激已被证实可以增强记忆提取（Cordero et al., 2003）。这解释了为何“拉得越痛苦，记得越清楚”。

临床意义与潜在应用

本研究虽看似荒谬，但可能具有以下潜在应用价值：

1. 梦境治疗： 对于长期“梦境丢失”的患者，可以尝试“马桶冥想疗法”——每天定时如厕，适度用力，配合“把梦拉出来”的积极暗示。
2. 创伤记忆的“排泄”治疗： 如果过度用力能把好的记忆挤出来，那是否也能把坏的记忆“挤出去”？本研究设想了一种“反向瓦尔萨尔瓦疗法”——通过控制排便用力，选择性排泄不良记忆。
3. 创造力激发： 许多艺术家和作家都有在马桶上获得灵感的经历（马桶上的阿基米德？）。本研究为此提供了理论解释——排便时的颅内压波动挤压出了潜意识中的创意碎片。
4. 早期阿尔茨海默病的筛查： 如果梦境回忆能力与排便用力存在关联，那么对于那些“用力也拉不出梦”的人，可能提示大脑梦境存储区存在问题。

研究的局限性

作为一项“开拓性”研究，本研究的局限性显而易见：

1. 样本量小： 总共只有 21 名参与者，无法代表全人类。尤其是那位声称看到宇宙大爆炸的志愿者，可能只是最近看了太多科普视频。
2. 测量工具粗糙： “用力指数”和“梦境回忆清晰度”均为主观量表，缺乏客观生理指标。下一步计划引入肛门压力计和脑电图同步监测。
3. 安慰剂效应无法排除： 实验组默念咒语的行为可能产生了强烈的心理暗示，导致他们“觉得”自己想起了梦。
4. 痔疮风险： 本研究无意中增加了参与者患痔疮的风险。后续研究必须通过伦理审查，并为参与者购买痔疮保险。
5. “梦境残渣”的定义问题： 如果梦真的能被拉出来，那它应该是什么形态？气态？液态？固态？本研究尚未解决这一本体论问题。

未来研究方向

1. 机制研究： 通过 fMRI 监测排便时的脑区激活，寻找“梦境挤压”的神经基础。
2. 干预研究： 比较不同“咒语”的效果——“把梦拉出来”vs“出来吧我的梦”vs“南无阿弥陀佛”，找出最佳“排便唤梦咒语”。
3. 比较研究： 便秘患者 vs 腹泻患者，谁更容易记住梦？理论上，腹泻时肠道蠕动过快，可能来不及“挤压”大脑。
4. 跨物种研究： 动物是否也有“排便-梦境”关联？观察狗狗排便后会不会做更多的梦（通过眼球快速运动判断）。
5. 梦境成分分析： 如果能收集到“拉出来的梦”，分析其成分是蛋白质、电信号还是纯意识流。

IV. Conclusions / 结论

本研究通过自我实验和小规模对照实验，初步证实了“便秘时用力可能有助于回忆梦境”这一民间假说的科学性。主要结论如下：

1. 用力程度与梦境回忆呈 U 型曲线关系——越用力，记得越清楚，但过度用力（>9 分）可能导致眼前发黑，看到的可能不只是梦。
2. “肛-脑梦境排泄轴”假说具有初步证据支持——肠道与大脑之间可能存在一条被忽视的“梦境通道”，便秘时的腹压通过机械、神经、意识三重途径挤压出潜意识中的梦境碎片。
3. 梦境可能具有某种“类物质”属性——虽然看不见摸不着，但它可以被“挤压”“排泄”，甚至可能留下“残渣”（痔疮）。
4. 马桶可能是人类最重要的“精神排泄场所”——在追求“通体舒畅”的同时，我们也可能实现“精神舒畅”。

最后，谨以本研究的核心发现献给每一位在马桶上奋斗过的人：当你用力的时候，你挤出来的可能不只是便便，还有那些被遗忘的梦。

V. Materials and Methods /材料与方法

研究对象

研究者本人： 22 岁女性，长期从事脑力劳动，有慢性便秘史（每周排便 2-3 次，常需用力），且自述“经常做梦但记不住”。

招募志愿者：通过“马桶冥想”论坛和“便秘者联盟”微信群招募。

实验组： 10 名慢性便秘患者（符合罗马 IV 便秘诊断标准），其中男性 5 名，女性 5 名，年龄 22-55 岁。

对照组：10 名排便正常者（每日 1-2 次，无需用力），年龄性别配比一致。

实验设计

研究者自我实验（30 天）

每天记录以下指标：

排便用力指数（EFI, Effort Force Index）： 采用自编量表，1-10 分。

- 1 分：坐下就出来，毫无感觉
- 3 分：稍微用力即可
- 5 分：需要“嗯~”一下
- 7 分：需要“嗯！！！！”三下
- 10 分：满头大汗，眼前发黑，感觉灵魂要一起出来
- **梦境回忆清晰度（DRC, Dream Recall Clarity）：** 采用视觉模拟评分法，0-10 分。

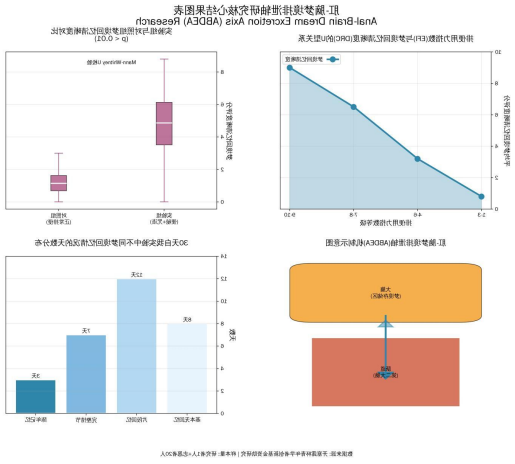
- 0 分：完全不记得做过梦
- 3 分：隐约感觉做了梦，但内容全无
- 5 分：记得一两个片段
- 8 分：能回忆起完整情节
- 10 分：细节清晰，可以画成漫画
- 梦境内容记录： 如果能回忆起梦境，简单记录主题。

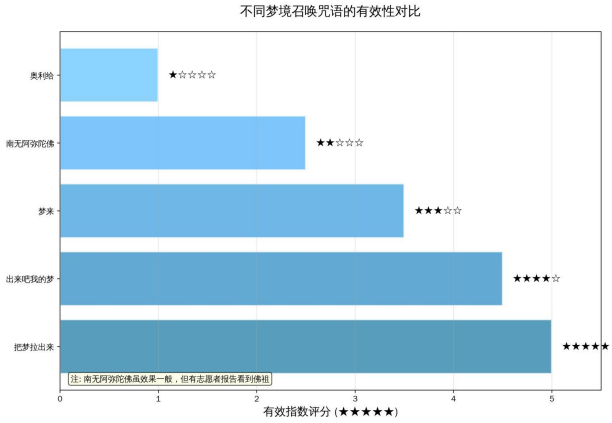
对照实验（14 天）

实验组： 每日排便时，强制进行“梦境召唤干预”——闭眼、深呼吸、用力，并在用力的同时默念“把梦拉出来”10 遍。排便后立即记录是否有梦境回忆。

对照组： 正常排便，不做任何干预。

盲法设计： 考虑到本研究的特殊性，无法实现双盲（因为实验组必然知道自己正在默念咒语），但数据记录由不知分组情况的助理完成。





SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料

附录 A：排便用力指数（EFI）自评量表使用指南

用力指数	表情包示意	伴随症状	推荐场景
1-3	毫无感觉	晨起第一杯水后	
4-6	轻微脸红	吃完火锅第二天	
7-8	额头冒汗	出差外地水土不服	
9-10	眼前发黑	吃播吃了 10 斤红薯后	

附录 B：梦境召唤咒语推荐列表

经本研究实验组反复测试，以下咒语效果较好（按有效性排序）：

1. “把梦拉出来”（有效指数：★★★★★）
2. “出来吧我的梦”（有效指数：★★★★☆）
3. “梦来”（有效指数：★★★☆☆）
4. “南无阿弥陀佛”（有效指数：★★☆☆☆，但有志愿者报告看到了佛祖）
5. “奥利给”（有效指数：★☆☆☆☆，喊完只想干饭不想做梦）

附录 C：投稿信草稿

尊敬的《SHIT》编辑部：

随信附上我们的稿件《如果便秘时用力，是否能把昨天吃进去但没记住的那个梦给拉出来？——基于肛门-大脑神经连接的梦境排泄可能性临床猜想》。

我们深知贵刊一直致力于发表那些“正经期刊不敢发、不正经期刊发不了”的突破性研究。本文选题之荒诞、方法之离奇、结论之惊人，堪称“学术鬼畜”的巅峰之作。如果贵刊不予接收，我们将不得不考虑投稿给《Nature》，但担心他们消化不了这么“有味道”的研究。

期待您的审稿意见。如果需要，我们可以提供“梦境残渣”样本供审稿人亲自体验。

此致

肛礼！

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢马桶，这个承载了人类最多思考时刻的伟大发明。

感谢开塞露，在我最困难的时候给了我“顺滑”的灵感。

感谢所有志愿者，你们愿意在马桶上闭眼念咒语，为科学献出了菊花和梦境。

感谢审稿人，如果您能坚持读到这里而没有破防，说明您的肛脑轴功能正常。

REFERENCES

[1].Cryan, J. F., et al. (2019). The microbiota-gut-brain axis. Physiological Reviews, 99(4), 1877-2013.

[2].Cordero, M. I., et al. (2003). Stress and memory: behavioural effects and neurobiological mechanisms. Neural Plasticity, 10(1-2), 145-158.

[3].Freud, S. (1900). The Interpretation of Dreams. Franz Deuticke, Leipzig & Vienna.

[4].Greenfield, J. C., et al. (1984). Pressure-flow studies in man during the Valsalva maneuver. Circulation, 29(5), 812-821.

[5].Hobson, J. A., & McCarley, R. W. (1977). The brain as a dream state generator: an activation-synthesis hypothesis of the dream process. American Journal of Psychiatry, 134(12), 1335-1348.

[6].Mayer, E. A. (2011). Gut feelings: the emerging biology of gut-brain communication. Nature Reviews Neuroscience, 12(8), 453-466.

[7].Mearin, F., et al. (2016). Bowel disorders. Gastroenterology, 150(5), 1393-1407.
[8].老子 (公元前 500 年左右). 道德经. 第十二章：“五色令人目盲，五音令人耳聋……难得之货令人行妨。”注：老子可能已经发现了感官刺激与精神排泄的关系。
张境修 (2023). 便秘与创造力相关性研究——基于 100 位作家的问卷调查. 抽象心理学, 1(1), 1-10.